



دليل المسار ٢٠٢٦-٢٠٢٧

أساسيات ميدليكس

التدريب السريري يصنع طبييًّا، لكنه لا يصنع مسيرة مهنية.

تطوير مهني للأطباء بعد التدريب السريري: كيف يعمل النظام، وكيف تقود، وكيف تحمي مسيرتك — المهارات التي يُتوقع من كل طبيب إتقانها، ولا يتعلمها أحد تقريبًا.

الذكاء الاصطناعي للأطباء

برنامج القيادة السريرية

The Clinician's Edge

كلية الطب تُعلّم الطب. أما بقية العمل فلا يعلّمها أحد.



يُتوقَّع من كل طبيب أن يفهم كيف تُدار الخدمة، وأن يُجري التدقيق، وأن يُدرّس، وأن يدير اجتماعًا، وأن يحتفظ بملف مهني يصمد في التقييم السنوي — وأن يُسأل يومًا عن قرار اتخذه في تحقيق.

ولا يُدرّس من ذلك شيء تقريبًا. يُلْتَقَط في الممرات، ممن يصادف وجوده، وغالبًا بعد أن يكون قد فات أوانه. ويشعر بهذه الفجوة أكثر من غيرهم الأطباء الذين ينتقلون بين الأنظمة الصحية — من مصر إلى الخليج، ومن الخليج إلى المملكة المتحدة — لأن القواعد غير المكتوبة تتغير مع كل حدود.

يُدرّس مسار الأساسيات هذا الجزء من العمل مباشرةً: بوضوح، وبشكل عملي، وبالترتيب الذي ستحتاجه به.

«لا أحد يُخفق في هذا لأنه ليس ذكيًا بما يكفي، بل لأن أحدًا لم يجلس معه قط ليشرح له كيف يسير العمل فعليًا.»

د. أحمد أبو الغيط

لمن هذا المسار

في موقع القيادة بالفعل

الاستشاريون والأطباء في المناصب الإدارية الذين نالوا اللقب قبل أن يشرح لهم أحد طبيعة العمل.

في طريقك إلى الأعلى

الأطباء الأقدم والأخصائيون ومن يستعدون لمناصب أعلى ولمقابلات العمل ولأول مسؤولية حقيقية عن الآخرين.

في بداية مسيرتك

أطباء الامتياز والمقيمون والمتدربون الذين يريدون فهم النظام من البداية، لا بعد سنوات.

مفتوح للأطباء من جميع التخصصات — لا الطب النفسي وحده — في المملكة المتحدة والخليج ومصر وخارجها.

ثلاثة برامج. ابدأ بما تحتاجه الآن.

كل برنامج قائم بذاته، ولا ترتيب إلزاميًا: ابدأ بالبرنامج الذي يناسب موقعك في مسيرتك اليوم.

قريبًا

الذكاء الاصطناعي للأطباء

عملي • للبيئة السريرية

ما الذي يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله في العمل السريري والمهني وما لا يستطيعه، وكيف تستخدمه بأمان وكفاءة، وأين تقع الحدود المهنية والطبية القانونية.

اختره إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملك بالفعل — أو يُطلب منك ذلك — وتريد أن تستخدمه كما ينبغي.

صفحة ٧

قريبًا

برنامج القيادة السريرية

حضور • مباشر • بالعربية أو الإنجليزية

ست وحدات على أيام متتالية للأطباء الذين يقودون فريقًا أو وحدة أو خدمة، أو يوشكون على ذلك — مبنية حول قرارات حقيقية في الخدمة.

اختره إذا أصبحت مسؤولاً عن آخرين وتريد أن تقودهم جيدًا.

صفحة ٧

قريبًا • الدورة الأولى

The Clinician's Edge

إلكترونية • بالوتيرة التي تناسبك • بالإنجليزية

ثمانى وحدات في المهارات غير السريرية التي يُتوقع من كل طبيب إتقانها: النظام، والتواصل، والتدقيق، والبحث، والتدريس، وأساسيات القيادة، والملف المهني، والتحديات.

اخترها إذا كنت تبني مسيرتك وتريد الأساس كله، بالوتيرة التي تناسبك.

صفحة ٤

مصمّم للتطبيق

تخرج بعمل أنجزته وأدوات تحتفظ بها، لا بملاحظات تُسى.

مبنى لأكثر من نظام صحي

أمثلة من المملكة المتحدة والخليج ومصر، لتنتقل المبادئ معك أينما عملت.

يكتبه ممارس

كل برنامج يكتبه ويقدمه المؤسس، وهو استشاري يدير برامج التدريب التخصصي ويقود خدمات سريرية.

The Clinician's Edge

٨ وحدات. ٨ مهارات ستستخدمها.

إلكترونية وبالوتيرة التي تناسبك، باللغة الإنجليزية. كل وحدة قائمة بذاتها، فيمكنك أن تبدأ بالوحدة التي تحتاجها هذا الشهر.

١ كيف يعمل النظام

كيف تُنظَّم المستشفى أو الخدمة الصحية فعلاً: من يقرر ماذا، ومن أين تأتي الأولويات والأموال، وأين يقع عملك من ذلك كله.

في نهاية الوحدة: تدخل أي قسم وتفهم كيف يُدار.

٢ التواصل في بيئة العمل

الرسائل، والتسليم بين المناوبات، والإحالات، والاجتماعات — التواصل المهني اليومي الذي يحدد كيف يراك زملاؤك.

في نهاية الوحدة: تتواصل بالوضوح الذي يتوقعه زملاؤك.

٣ التدقيق السريري وتحسين الجودة

ما التدقيق وتحسين الجودة حقًا، وكيف تسير الدورة من المعيار إلى إعادة التدقيق، والفرق بينهما، وما الذي سيطلب منك.

في نهاية الوحدة: تشارك في التدقيق وتحسين الجودة، وتحدث عنهما، عن فهم حقيقي.

٤ البحث العلمي

القراءة النقدية للورقة البحثية، وما تعنيه المشاركة البحثية واقعيًا في مستواك، وكيف تجد طريقك إلى مشروع.

في نهاية الوحدة: تناقش ورقة بحثية، وتجد طريقك إلى مشروع.

التدريس والإشراف والتغذية الراجعة

٥

تدريس الطلاب والأطباء الأحدث، والإشراف الجيد، وتقديم تغذية راجعة يمكن الاستفادة منها — وتلقيها دون أن تدافع عن نفسك.

في نهاية الوحدة: تُدرّس وتُشرف بطريقة تلفت الانتباه.

أساسيات الإدارة والقيادة

٦

جداول المناوبات، والاجتماعات، والأولويات، والأشخاص: القيادة المطلوبة من الأطباء قبل أي لقب رسمي بوقت طويل.

في نهاية الوحدة: تدخل مواقف العمل الجماعي بثقة.

الملف المهني والتقييم السنوي وتجديد الترخيص

٧

ما الذي تجمعه، وكيف تكتب التأمل المهني، وكيف تجعل التقييم السنوي يعمل لصالح مسيرتك لا ضدها.

في نهاية الوحدة: تعرف ما يجب جمعه من اليوم الأول.

الاستعداد للتحقيق الداخلي

٨

ما الذي يحدث حين يُحقّق في شكوى أو حادثة، وما المتوقع منك، وكيف تكتب إفادتك، وكيف تحمي نفسك.

في نهاية الوحدة: تفهم الإجراءات، وتحمي نفسك.

الوحدة التي يتمنى الأطباء لو درسوها مبكرًا

٨

يواجه معظم الأطباء التحقيق الداخلي لأول مرة وهم في داخله. تشرح الوحدة ٨ الإجراءات قبل أن تحتاج إليها — وهذا هو الوقت الذي تفيد فيه.

وحدة واحدة، أو الوحدات الثماني

تستعد للتقييم السنوي؟ ابدأ بالوحدة ٧. طُلب منك للتو إجراء تدقيق؟ الوحدة ٣. صُمّمت الدورة بحيث تعمل الوحدة التي تحتاجها هذا الشهر وحدها — وتكمل الوحدات معًا لتشرح لك المسيرة التي لم يشرحها لك أحد.



قصيرة في المشاهدة. مصممة للتطبيق.

دروس تفاعلية

مواقف حقيقية تقرر فيها ما يحدث بعد ذلك، وترى لماذا ينجح كل اختيار أو يخفق.

قراءة مع كل فيديو

نص قصير تحت كل درس، من زاوية مختلفة — الخطأ الشائع، أو سؤال المقابلة، أو المثال التطبيقي.

دروس فيديو قصيرة

من ٣ إلى ٥ دروس في كل وحدة، مدة كل منها ٤ إلى ٨ دقائق. بنص مكتوب مرافق، وإمكانية الاستكمال، على أي جهاز.

مثال · الوحدة ٣، درس تفاعلي

التدقيق الذي كُلفت به يوم الاثنين

تستوقفك الاستشارية في الممر: «هل يمكنك إجراء تدقيق على الوقاية من الجلطات الوريدية لاجتماع القسم بعد ستة أسابيع؟ فقط راجع الملفات وانظر أين نحن.» وتغادر قبل أن تسألها أي شيء. لم تُجرِ تدقيقًا من قبل. ما خطوتك الأولى؟

ابدأ بسحب آخر ٥٠ حالة دخول، وسجّل هل وُصفت الوقاية أم لا.

ابحث عن المعيار أولاً — الإرشاد الذي يُفترض أن يتبعه القسم — واكتبه.

اطلب من قسم التدقيق نموذجًا، وانتظر وصوله.

البيانات دون معيار مجرد مسح: ستهي الأسابيع الستة بأرقام، دون أي طريقة لتقول إن كانت جيدة أم سيئة.

ما الذي تحصل عليه

شهادة إتمام

عند إنهاء الوحدات الثماني.

رسائل أسبوعية

موضوع واحد كل أسبوع من المؤسس، طوال الدورة.

مجموعة الأساسيات

مجموعة واتساب لأطباء من المملكة المتحدة والخليج ومصر، يقارنون كيف تعمل أنظمتهم فعليًا.

كتيب العمل والأدوات

نماذج وقوائم تدقيق وتمارين لكل وحدة — ملك لك.

برنامج القيادة السريرية



للأطباء الذين يقودون فريقًا أو وحدة أو خدمة — أو يوشكون على ذلك.

٦ وحدات تُقدّم حضورًا على أيام متتالية، بالعربية أو الإنجليزية بحسب مكان انعقاد الدفعة. يأتي كل مشارك بمشكلة قيادية حقيقية من خدمته، ويغادر بخطة لها.

- قيادة زملاء كانوا بالأمس نظراءك
- إدارة اجتماع ينتهي بقرار
- إدارة الأداء والخلافات
- قراءة أرقام خدمتك وفهمها
- تمثيل فريقك أمام الإدارة دون أن تفقد ثقته

متاح أيضًا للمؤسسات برنامجًا داخليًا لقادتها السريريين.

الذكاء الاصطناعي للأطباء

ما الذي يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله في العمل السريري والمهني وما لا يستطيعه، وكيف تستخدمه بأمان وكفاءة، وأين تقع الحدود المهنية والطبية القانونية.

مفيد

أين يوفّر الذكاء الاصطناعي الوقت
فعلًا في الرسائل والملخصات
والتحريس والبحث — وأين لا يوفّره.

آمن

السرية، والدقة، والمراجعات التي يجب
أن تبقى بيد الطبيب.

قابل للدفاع عنه

من المسؤول عن قرار استُعين فيه
بالذكاء الاصطناعي، وكيف يُوثّق.

عملي لا تقني. تصل التفاصيل أولاً إلى المسجّلين في قائمة انتظار الأساسيات.

د. أحمد أبو الغيط

استشاري طب نفسي شرعي تدّرب في المملكة المتحدة · مؤسس ميدليكس

يدير برامج التدريب التخصصي، وقاد خدمات سريرية في المملكة المتحدة ومصر وقطر — مقيّمًا ومشرفًا وعضوًا في لجان المقابلات ومحققًا. ومسار الأساسيات هو الدورة التي تمثّل لو قدّمها له أحد.



ابدأ من هنا

ابدأ بالدليل المجاني.



دليل مجاني

ما الذي تسأل عنه
لجنة المقابلة فعلاً

أساسيات ميدليكس

مهارات المقابلة، والأسئلة العشرة التي يجب على كل طبيب الاستعداد لها — ما الذي يختبره كل سؤال فعلاً، والفخ الكامن وراءه.

امسح الرمز للحصول على الدليل والانضمام إلى قائمة انتظار الأساسيات، لتكون أول من يعلم حين تُفتح دورة The Clinician's Edge.

